

CARDIOLOGIE

Hypertension Artérielle

Année 2025-2026

ITEM 224

LÉGENDE

- ★ Déjà tombé aux ECN
- ◆ Notion à haut rendement
- ⚠ Piège classique

Item 224

Plan du cours

Cardiologie · Hypertension Artérielle

I Définition et épidémiologie

Cadre nosologique de l'HTA et poids de santé publique.

- A. Définitions et seuils** — Seuils tensionnels et grades.
- B. Épidémiologie** — Prévalence et facteurs de risque.

II Diagnostic et bilan initial

Confirmation diagnostique et recherche du retentissement.

- A. Mesure de la pression artérielle** — Conditions de mesure et MAPA.
- B. Bilan de retentissement** — Atteinte des organes cibles.

III Prise en charge thérapeutique

Mesures hygiéno-diététiques et traitement médicamenteux.

- A. Mesures non médicamenteuses** — Règles hygiéno-diététiques.
- B. Traitement médicamenteux** — Classes et stratégie d'association.

I | Définition et épidémiologie

I	A. Définitions et seuils												
★ Définition de l'HTA	• Hypertension artérielle (HTA) : pression artérielle systolique (PAS) $\geq$ 140 mmHg et/ou diastolique (PAD) $\geq$ 90 mmHg au cabinet • diagnostic confirmé sur deux consultations distinctes • en automesure, seuil abaissé à $\geq$ 135/85 mmHg												
◆ Grades de sévérité	<table><tr><th>Grade</th><th>PAS (mmHg)</th><th>PAD (mmHg)</th></tr><tr><td>Grade 1</td><td>140-159</td><td>90-99</td></tr><tr><td>Grade 2</td><td>160-179</td><td>100-109</td></tr><tr><td>Grade 3</td><td>$\geq$ 180</td><td>$\geq$ 110</td></tr></table>	Grade	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)	Grade 1	140-159	90-99	Grade 2	160-179	100-109	Grade 3	$\geq$ 180	$\geq$ 110
Grade	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)											
Grade 1	140-159	90-99											
Grade 2	160-179	100-109											
Grade 3	$\geq$ 180	$\geq$ 110											
⚠ HTA blouse blanche	• élévation tensionnelle au cabinet uniquement • à confirmer par MAPA ou automesure • ⚠ à ne pas confondre avec l'HTA masquée (normale au cabinet, élevée en ambulatoire)												

I	B. Épidémiologie
Prévalence	• environ 30 % de la population adulte • augmente avec l'âge • premier motif de consultation en médecine générale
◆ Facteurs de risque	• Non modifiables : âge, sexe masculin, hérédité • Modifiables : surpoids, sédentarité, consommation de sel, alcool, tabac

II | Diagnostic et bilan initial

II	A. Mesure de la pression artérielle
Conditions de mesure	• patient au repos depuis 5 minutes, assis • brassard adapté à la circonférence du bras • mesure aux deux bras lors du bilan initial
★ MAPA	• mesure ambulatoire de la PA sur 24 h • examen de référence pour confirmer le diagnostic • dépiste l'HTA masquée
Automesure	• règle des 3 : 3 mesures matin et soir, 3 jours de suite

II	B. Bilan de retentissement
◆ Organes cibles	• Cœur : ECG, hypertrophie ventriculaire gauche • Rein : créatininémie, DFG, protéinurie • Œil : rétinopathie hypertensive si HTA sévère
Bilan biologique	• kaliémie, glycémie à jeun • bilan lipidique, créatininémie
⚠ HTA secondaire	• à rechercher si HTA résistante, sujet jeune ou signes d'orientation

III | Prise en charge thérapeutique

III	A. Mesures non médicamenteuses
Règles hygiéno-diététiques	• réduction des apports en sel (< 6 g/j) • perte de poids en cas de surpoids • activité physique régulière (30 min/j) • limitation de l'alcool, arrêt du tabac

III	B. Traitement médicamenteux		
★ Classes de 1re intention	Classe	Exemple	Indication préférentielle
	IEC	Ramipril	Diabète, insuffisance cardiaque
	ARA II	Losartan	Intolérance aux IEC (toux)
	Inhibiteur calcique	Amlodipine	Sujet âgé
	Diurétique thiazidique	HCTZ	Sujet âgé
◆ Stratégie thérapeutique	• bithérapie d'emblée souvent recommandée • privilégier les associations fixes • objectif : < 140/90 mmHg, voire < 130/80 mmHg si bien toléré		

Synthèse — Tableaux de révision

Grades de sévérité de l'HTA

Grade	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)
Grade 1	140-159	90-99
Grade 2	160-179	100-109
Grade 3	≥ 180	≥ 110

Classes thérapeutiques de première intention

Classe	Exemple	Indication préférentielle
IEC	Ramipril	Diabète, insuffisance cardiaque
ARA II	Losartan	Intolérance aux IEC (toux)
Inhibiteur calcique	Amlodipine	Sujet âgé, sujet noir
Diurétique thiazidique	Hydrochlorothiazide	Sujet âgé
Bêtabloquant	Bisoprolol	Coronaropathie associée

L'ESSENTIEL

À retenir absolument

Hypertension Artérielle

- L'**HTA** est définie par une PA $\geq$ **140/90 mmHg** au cabinet, confirmée sur des mesures répétées.
- La **MAPA** et l'**automesure** confirment le diagnostic et dépistent l'HTA blouse blanche et l'HTA masquée.
- Le bilan initial recherche systématiquement une **atteinte des organes cibles** et une **HTA secondaire**.
- Les **règles hygiéno-diététiques** sont la base du traitement, toujours associées aux médicaments.
- Cinq classes de première intention ; la **bithérapie** est souvent instaurée d'emblée.
- L'objectif tensionnel est $<$ **140/90 mmHg**, idéalement $<$ **130/80 mmHg** si la tolérance le permet.



MAJOR ECN · 2025-2026